



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : امل حسن محمود عنبر

المحافظة : الشرقيه الحى / المدينة : العاشر من رمضان

رقم البطاقة : 26401040104642 رقم التليفون : 01023226623 تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026 العمر(تاريخ الميلاد) : 04-01-1964 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإخصائي الاجتماعي التوقيع: (-----) المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع: (-----)
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع: (-----)
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع: (-----)
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة. تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / أ.د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: امل حسن محمود عني National ID: 26401040104642	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

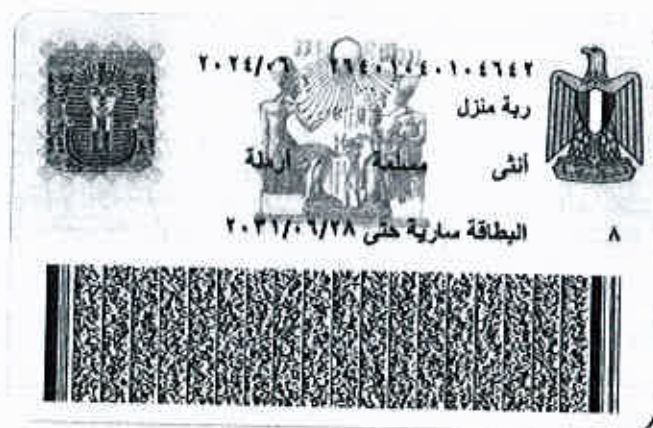
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient Name : الأستاذ / أمل حسن محمود عنبر
Patient No. : 26401040104642
Path No. : 3336/25
Sex : Female
Age : 61 Y
Referring Doc :

Request No. : 13000759
Request Date : 02/11/2025
Verification Date : 23/11/2025
Financial Category : جوسف روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post-NACT
Nature Specimen: Left breast conservative surgery, extra-medial margin & axillary lymph nodes dissection.

Gross Examination:

- Left breast conservative surgery specimen measured 13x12x3.5 cm, with covering skin ellipse measured 5x2.5 cm.
- * Serialling showed a wire guided tumor bed site measured 3x2x2 cm, located 0.3 cm from the least medial margin & surrounded by rubbery grey white area 12x10 cm.
- Extra-medial margin: Fibrofatty tissue piece measured 7x6x1 cm, looked unremarkable grossly.
- Axilla: Aillary fat measured 8x7x2 cm, entangling 12 lymph nodes, the largest was 1.5x1x0.5 cm.
- * 23 Blocks:
- 1- Superior margin., 2- Inferior margin., 3- Lateral margin., 4- Medial margin., 5- Deep margin., 6- Superficial margin., 7- Extra-medial margin., 8:19- TBS., 20- Skin., 21:23- ALNs.
- Gross was done by; Dr. Heba Hassan.

- * Frozen (Intra-operative) Results:
- Suspicious medial margin.
- Free all other surgical margins.

Microscopic Examination:

- * Histological type: No residual viable remnants of the previously diagnosed tumor.
- Cellularity (0%).
- * Angioinvasion: Absent.
- * Ductal carcinoma in situ: Absent.
- * Surgical margins: Free extra-medial margin & all other surgical margins.

Verified by :

Dr. Duaa Mohamed

Printing By : Mrs. Mayada Hegaz

Printing Date : 29/11/2025 12:21:38

Page 1 of 2



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name: <u>أمل حسن محمود عنبر</u>		
MR. : <u>4452</u>		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 60-year-old with a history of left-sided breast cancer, clinical stage T2 N1 M0, estrogen-receptor positive (23 %), HER2-positive (25 %). Initial management included left breast-conserving surgery on 01/11/2025 followed by adjuvant chemotherapy, trastuzumab (Herceptin) and an aromatase inhibitor (Arimidex). The treatment plan documented a recommendation for continuation of trastuzumab subcutaneously (SC) and Arimidex, with pharmacy dispensing scheduled for cycles 11, 12, and 13. The patient attended a pharmacy visit for Cycle 12, receiving Herceptin SC, Anastrozole, and supportive medications as prescribed. On 21/04/2026 the patient was scheduled for a dental extraction prior to Cycle 14, during which Herceptin 600 mg SC and Arimidex were administered. On 25/07/2026 the patient received Cycle 17 of Herceptin 600 mg SC together with Arimidex and supportive therapy; an echocardiogram performed on 22-07-2026 showed a left ventricular ejection fraction of 66 % with a plan for annual cardiac assessment in October. The patient has now completed 17 cycles of Herceptin.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	20-09-2026 التاريخ :
	dina makram	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذ / امل حسن محمود غنبر
Patient No. : 26401040104642
Path No. : 3336/25
Sex : Female
Age : 61 Y
Referring Doc :

Request No. : 13000759
Request Date : 02/11/2025
Verification Date : 23/11/2025
Financial Category : جوسفات روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

- * Axillary lymph nodes: Twelve free lymph nodes, LNs (0/12).
- * Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.

Diagnosis:

Left breast cancer (Post-NACT), Left breast conservative surgery, Extra-medial margin & Axillary lymph nodes dissection:

- No residual viable remnants of the previously diagnosed tumor.
- Ductal carcinoma insitu: Absent.
- Surgical Margins: All are free.
- Axillary lymph nodes: Free 12 lymph nodes, LNs (0/12).
- Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.
- Stage: ypT0, ypN0.

Signature:

Prof. Dr. Gamal Abd-El-Aty.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy

Printing Date : 29/11/2025 12:21:38

Page 2 of 2



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name: Amal Hassan Mahmoud Anbar	Date : 11/10/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 61 Year(s)
Medical ID: 275/2025	Pat. ID: 98147

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after neoadjuvant chemotherapy of pathologically proved LEFT breast carcinoma.

- **Breast density:** scattered fibroglandular ACR B
- **AN ARCHITECTURAL DISTORION IS NOTED AT THE CLIP SITE AT THE LEFT UPPER OUTER QUADRANT**
- No detected suspicious mass density, architectural distortion or pathological micro-calcification.
- Normal skin and nipple.

By complementary breast ultrasound:

- **Still noted hypoechoic irregular mass at the site of the clip at 1 o'clock zone b, now measuring 2.5 x 0.9 cm**
- **No other suspicious masses in other quadrants.**
- **No detected suspicious masses in the right breast.**
- Normal skin, subcutaneous fat and nipple areola complex on both sides.
- **No detected significant axillary lymph nodes.**

Conclusion:

- Left pathologically proven mass is still noted by ultrasound(BIKARDS 6 category).
- Normal study of the right breast (BIRADS 1 category).

• Dr farah elshobaky

ECHO REPORT

NAME : د. محمد حسن DATE: 28 / 10 / 2025
ID NUMBER : ٢٧٥ / ٢٥ SEX : ♀ AGE: ٦١

EF	64%	55-75%	PWT	٠.8	0.6-1.1cm
LVEDD	4.5	3.5-5.8cm	AO.R	2.3	3-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.2	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3com(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

- LV Dimensions normal
- LV Wall Thickness normal
- LV Diastolic Function DD grade I
- SWMA SWMA
- LA and Ao Root Dimensions normal
- Mitral Valve normal
- Aortic Valve normal
- Tricuspid Valve TR
- Pulmonary Valve normal
- Right Side and Systolic Function normal
- Intracardiac Masses and Effusion normal

DR.
[Signature]



MDT form

MDT ID: 26401040104642
Patient Name: أمل حسن محمود علي

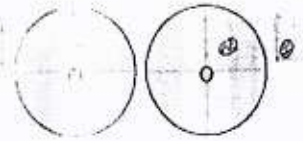
Sex:

3- Medical number:
Female

83257141
Old Med :

Old Med :
275-2025

Patient Age : 61 Y



Family History	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	Reason of MDT	Reason of MDT
Family History	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	Reason of MDT	Reason of MDT
Family History	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	Reason of MDT	Reason of MDT
Family History	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	Reason of MDT	Reason of MDT
Family History	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	Reason of MDT	Reason of MDT
Family History	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	Reason of MDT	Reason of MDT
Family History	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	Reason of MDT	Reason of MDT
Family History	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	Reason of MDT	Reason of MDT
Family History	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	Reason of MDT	Reason of MDT
Family History	Family History	Phone	Phone	BMI	BMI	Reason of MDT	Reason of MDT

Clinical data

Imaging :
Mets Workup :
ct:bilateral pulmonary nodules
pet ct:free

ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Rig7
3/S	0/8	3		25
ER COMMENT	PR COMMENT	Her 2 Neu COMMENT	SISH COMMENT	

Immunology

IMMUNITY
TESTS
CERTIFICATION

MDT OUTCOME & PLAN

MDT X6 FOLLOWEDED BY LT BCS

SIGNATURE

ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	Pathology



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

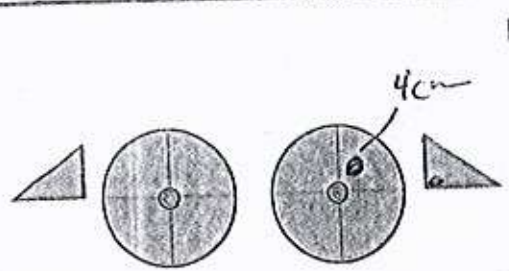
الاستشارة
طبية
مصر

MDT FORM

16 / 3 / 2025 G ١٠

Name	أحمد محمد	MRN	
Age	٦٠	ID	C.C.D/C.V.O
Menopausal status	Post	Phone	٠١٠٠٨٨٤٥٤٢
His Score		Marital status	Married
Sex		Family history	-ve
Morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

T2N1M0				
PR:	HER 2:	Ki67:		
0/8	3+	25%		
Mammography: 2/3 ACR B				
Pathological level I&II up to 2cm				
Workup: bilat pulmonary nodules				
CT: free				

Recommendations:

Clip insertion

OUTCOME & PLAN

NACT TCTp

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric